

TEMA 3.21 • OBSTETRICIA

Espectro de la Placenta Acreta

PERFIL EUNACOM 2.01.2.016
Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Espectro de la Placenta Acreta

Clasificación

TABLA 3.21.1: TIPO VS INVASIÓN		
TIPO	INVASIÓN	DETALLE
Acreta	Toca el miometrio (sin invadirlo)	La más frecuente
Increta	Invade el miometrio	Intermedia
Percreta	Atraviesa el miometrio	Puede invadir vejiga, recto, etc.

Factores de Riesgo

- Placenta previa (útero más delgado en el segmento inferior)
- Cesárea previa (cicatriz facilita la invasión)

Combinación de ambos → riesgo muy alto.

Clínica y Diagnóstico

Problema principal: La placenta **no se desprende** durante el alumbramiento → hemorragia puerperal grave.

TABLA 3.21.2: MOMENTO DEL DIAGNÓSTICO VS CÓMO	
MOMENTO DEL DIAGNÓSTICO	CÓMO
Preparto (ideal)	Ecografía obstétrica — placenta pegada al miometrio en paciente con FR
Intraparto	Alumbramiento fallido + hemorragia masiva

Manejo

Diagnosticado en el preparto

Conducta: Cesárea electiva + **histerectomía** programada a las **34–35 semanas**

- No se espera el término** (riesgo de rotura, sangrado, invasión progresiva)
- Corticoides antenatales** siempre (nacimiento < 34–35 sem)
- No intentar extraer la placenta manualmente (tracción → hemorragia masiva + inversión uterina)

Diagnosticado en el intraparto

Conducta: Al no salir la placenta → **histerectomía obstétrica de urgencia**

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

En el acretismo placentario **no se intenta tracción fuerte** para extraer la placenta. Está adherida profundamente → la tracción causa hemorragia masiva o inversión uterina. La histerectomía es la única solución definitiva.

Resumen

TABLA 3.21.3: DIAGNÓSTICO PRENATAL VS ECO + FR (PLACENTA PREVIA + CESÁREA PREVIA)	
DIAGNÓSTICO PRENATAL	ECO + FR (PLACENTA PREVIA + CESÁREA PREVIA)
Manejo	Cesárea + histerectomía a las 34–35 semanas
Complicación principal	Hemorragia puerperal grave

| **Nunca** | Tracción de placenta acreta |

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Respecto a Espectro de la Placenta Acreta, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA para el EUNACOM?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Espectro de la Placenta Acreta. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Clasificación
- Factores de Riesgo
- Clínica y Diagnóstico
- Manejo
- Diagnosticado en el preparto
- Diagnosticado en el intraparto
- | Toca el miometrio (sin invadirlo) | La más frecuente |

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (ESPECTRO DE LA PLACENTA ACRETA)**PREGUNTA 1**

Respecto a Espectro de la Placenta Acreta, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA para el EUNACOM?

- A)** El diagnóstico de Espectro de la Placenta Acreta se basa exclusivamente en criterios de laboratorio
- B)** El manejo inicial de Espectro de la Placenta Acreta debe orientarse según el estado clínico del paciente
- C)** Todo paciente con Espectro de la Placenta Acreta requiere hospitalización inmediata
- D)** El tratamiento de Espectro de la Placenta Acreta es igual en todas las edades y contextos clínicos
- E)** El seguimiento de Espectro de la Placenta Acreta no es necesario una vez iniciado el tratamiento

PREGUNTA 2

¿Cuál es el hallazgo más característico o criterio diagnóstico principal en Espectro de la Placenta Acreta?

- A)** Alteración exclusivamente en exámenes de laboratorio sin síntomas
- B)** Presentación clínica específica que orienta al diagnóstico según el perfil EUNACOM
- C)** Requiere siempre confirmación con biopsia o estudio histológico
- D)** Es un diagnóstico de exclusión que requiere descartar todas las otras causas primero
- E)** Solo se presenta en pacientes con factores de riesgo conocidos

PREGUNTA 3

Paciente consulta con cuadro compatible con Espectro de la Placenta Acreta. Según el perfil EUNACOM, ¿cuál es la conducta de seguimiento más apropiada?

- A)** Alta sin controles dado que es una condición autolimitada
- B)** Derivación inmediata al especialista en todos los casos
- C)** Control según evolución clínica y criterios del perfil EUNACOM para esta patología
- D)** Hospitalización preventiva en todos los casos para monitorización
- E)** Tratamiento de por vida sin necesidad de controles periódicos

RESUMEN: ESPECTRO DE LA PLACENTA ACRETA

1. Placenta previa (útero más delgado en el segmento inferior) 2. Cesárea previa (cicatriz facilita la invasión) Problema principal: La placenta no se desprende durante el alumbramiento → hemorragia puerperal grave. ::warning En el acretismo placentario no se intenta tracción fuerte para extraer la placenta. Está adherida profundamente → la tracción causa hemorragia masiva o inversión uterina. La histerectomía es la única solución definitiva. :::